PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

PANDUAN KEBERSIHAN TANGAN RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA					
Status Dokumen	**Status Review**	**Status Revisi**	**Tanggal Terbit**	**Tanggal Efektif**	**Tanggal Peninjauan Kembali**
Baru	00	00	30 Oktober 2024	30 November 2021	01 November 2024
Revisi	01	01	01 November 2025	01 Desember 2025	01 Desember 2028

Riwayat Revisi

Revisi	Penanggung Jawab	No Dokumen	Uraian Perubahan
00	Komite PPI	003/PER/DIR/PT.FMP-PHBW/X/2024	1. Pembuatan baru
01	Komite PPI	030/PER/DIR/PT.FMP-PHBW/XI/2025	1. Perubahan tanggal terbit 2. Perubahan konten

CONTROLLED

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMAYA
030/PER/DIR/PT.FMP-PHBW/XI/2025

TENTANG

PANDUAN KEBERSIHAN TANGAN
RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA

Menimbang :

1. Bahwa setiap kegiatan pelayanan rumah sakit haruslah berfokus pada pasien dan keselamatan pasien demi mencapai kepuasan dan keselamatan pasien
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit melalui pemberian pelayanan yang profesional, bermutu dan aman maka diperlukan Panduan Kebersihan Tangan di Rumah Sakit Primaya
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1, dan 2 tersebut dipandang perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Primaya

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan no 27 tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun
   tentang Keselamatan Pasien

CONTROLLED

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan	**:**	
Kesatu	:	PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMAYA TENTANG PANDUAN KEBERSIHAN TANGAN RUMAH SAKIT PRIMAYA
Kedua	:	Memberlakukan PANDUAN KEBERSIHAN TANGAN RUMAH SAKIT PRIMAYA sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 01 November 2025
Direktur Rumah Sakit

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

DR. AGUS MARVIANTO

CONTROLLED

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMAYA
NOMOR: 030/PER/DIR/PT.FMP-PHBW/XI/2025
TENTANG PANDUAN KEBERSIHAN TANGAN
RUMAH SAKIT PRIMAYA

PANDUAN KEBERSIHAN TANGAN
RUMAH SAKIT PRIMAYA

BAB I
DEFINISI

1. Cuci tangan adalah membersihkan tangan dari segala kotoran, di mulai dari ujung jari siku dan lengan dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan (Depkes 1987)
2. Kebersihan tangan: setiap metode yang bertujuan untuk menghilangkan atau menghnacurkan mikroorganisme pada tangan. Kebersihan tangan dapat dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun (*handwashing*), dan dengan *handrub* berbasis alkohol (*handrubbing*)
3. Mencuci tangan (*handwashing*): membersihkan seluruh permukaan tangan secara kuat dalam waktu singkat dengan sabun, diikuti dengan pembilasan di bawah air mengalir
4. *Handrubbing:* membersihkan seluruh permukaan tangan menggunakan
   handrub berbasis alkohol tanpa menggunakan air.
5. *Handrub* berbasis alkohol: cairan antiseptik berbasis alkohol untuk membersihkan tangan yang bereaksi cepat menghilangkan sementara atau mengurangi mikroorganisme dan melindungi kulit tanpa menggunakan air. Cairan ini biasanya mengandung alkohol 60-90%, pelembab *(emmolient*), pewangi dan seringkali antiseptik tambahan yang memiliki aksi residual.
6. Antiseptik: bahan kimia yang diaplikasikan di atas kulit atau jaringan hidup lainnya untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, sehingga mengurangi jumlah hitung bakteri total.

CONTROLLED

7. Air bersih: air yang secara alami atau kimiawi dibersihkan dan disaring sehingga aman untuk pemakaian karena memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Pada keadaan minimal, air bersih harus bebas dari mikroorganisme indikator dan memiliki turbiditas rendah (jernih, tidak berkabut) bahan antiseptik adalah:
   a. Alkohol 60 – 90% (etil dan isopropyl atau metil alkohol)
   b. Khlorheksidin glukonat 2 – 4%
   c. Khlorheksidin berbagai konsentrasi
   d. Iodium 3%
   e. Iodofor 7.5-10% berbagai konsentrasi
   f. Kloroksilenol 0.5-4%
   g. Triklosan
8. Pelembab (emmolient): cairan organik, seperti gliserol, propilen glikol atau sorbitol yang ketika di tambahkan pada handrub dan losion tangan, akan melunakkan kulit dan membantu mencegah kerusakan kulit (keretakan, kekeringan, iritasi dan dermatitis) akibat pencucian tangan dengan air dan sabun yang sering.
9. Sabun dan deterjen: produk-produk pembersih yang membantu melepaskan kotoran, debris dan mikroorganisme yang melekat sementara pada tangan. Sabun biasa memerlukan gosokan untuk melepas mikroorganisme secara mekanik, sementara sabun antiseptik selain melepas juga membunuh atau menghambat pertumbuhan dari hampir sebagian besar mikroorganisme.
10. Flora transien: mikrrorganisme yang diperoleh melalui kontak dengan pasien, petugas kesehatan atau permukaan yang terkontaminasi selama bekerja. Mikroorganisme ini tinggal di lapisan luar kulit dan terangkat sebagian dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air.
11. Flora residen: mikroorganisme yang tinggal di lapisan kulit yang lebih dalam serta di dalam folikel rambut, dan tidak dapat

CONTROLLED

dihilangkan sepenuhnya, bahkan dengan pencucian dan pembilasan sabun dan air bersih. Pada sebagian besar kasus, flora residen sangat kecil kemungkinannya terkait dengan penyakit infeksi yang menular dari udara, seperti flu burung. Tangan atau kuku dari sejumlah petugas kesehatan dapat terkolonisasi pada lapisan dalam oleh mikroorganisme yang menyebabkan infeksi seperti *Staphylococcus aureus*, bakteri batang Gram negatif atau ragi.

12. Cuci tangan steril: cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau cairan antiseptik dari ujung jari sampai siku yang dilakukan sebelum operasi oleh petugas kamar bedah untuk mengurangi mikroorganisme yang ada di tangan.

CONTROLLED

BAB II
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Kebersihan Tangan:

1. Metode Kebersihan Tangan:

   Kebersihan tangan dapat dilakukan dengan menggunakan sabun *(handwashing)* ataupun tidak yaitu dengan handrub berbasis alkohol *(handrubbing).* Teknik *handwashing* dan *handrubbing* memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. *Handwashing* merupakan metode yang dapat di gunakan pada tangan yang terlihat kotor, termasuk jika kintak dengan cairan tubuh. Teknik ini membutuhkan waktu yang relatif panjang dalam pelaksanaannya, yaitu sekitar 40 hingga 60 detik. Metode *handrubbing* tidak dapat dilakukan pada tangan yamg kotor dan berkontak dengan cairan tubuh, namun teknik ini memilikki kelebihan berupa pelaksanaan yang membutuhkan waktu lebih singkat, yaitu sekitar 20 hingga 30 detik, lebih cepat kering, dan dengan adanya kandungan alkohol, dapat melindungi seluruh permukaan tangan hingga bagian kuku.
2. Langkah-langkah kebersihan tangan

   Langkah-langkah melakukan kebersihan tangan mengacu pada *WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care tahun 2009*
3. Saat tepat melakukan kebersihan tangan

   Saat tepat melakukan kebersihan tangan mengacu pada *WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care tahun 2009*
4. Cuci tangan steril

   Cara melakukan cuci tangan setril sebelum pembedahan mengacu pada

   WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care tahun 2009
5. Pemantauan cara mencuci tangan

   Pemantauan cara mencuci tangan mengacu pada *WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care tahun 2009* dan di laporkan setiap bulan
6. Sosialisasi kebersihan tangan

CONTROLLED

Sosialisasi kebersihan tangan diberikan kepada karyawan, pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit. Sosialiasi dilakukan dengan berbagai metode seperti presentasi, demontrasi, leaflet dan poster kebersihan tangan.

CONTROLLED

BAB III
TATA LAKSANA

1. PRINSIP UMUM

Area fasilitas kebersihan tangan

a) Cairan berbasis alkohol:
   1) Unit Rawat Jalan
   2) Pintu masuk ruang rawat pasien
   3) Di setiap bed pasien rawat inap
   4) Rehab Medik
   5) Radiologi
   6) Poli Gigi
   7) Farmasi dan unit lain yg ada di rumah sakit Primaya

b) Cairan berbasis alkohol mengandung Chlorhexidin 0,5%
   1) Instalasi Gawat Darurat (IGD), NICU, ICU, HCU, HD di setiap bed IGD
   2) Laboratorium
   3) Kamar isolasi
   4) Unit Kamar Bedah

c) Sabun antiseptic mengandung Chlorhexidin 4%:
   1) Instalasi Gawat Darurat (IGD), NICU, ICU, HCU, HD.
   2) Unit Kamar Bedah
   3) Laboratorium
   4) Poli Gigi

d) Sabun antiseptic biasa:
   1) Kamar mandi
   2) Disposal
   3) Ruang linen kotor
   4) Kamar jenasah
   5) Unit rawat inap
   6) Unit rawat jalan

CONTROLLED

BAB IV

DOKUMENTASI

1. Fasilitas kebersihan tangan tidak memerlukan dokumentasi harian
2. Handrub dan Sabun yang belum di gunakan untuk kebersihan tangan, di simpan dalam lemari B3.

Referensi:

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2009: First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care.

Di tetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 01 November 2025
Direktur Rumah Sakit

DR. AGUS MARVIANTO

CONTROLLED

PRIMAYA HOSPITAL

	Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Nama	dr. Ignatius Pramudya W, SpOG	Dr. Eufracia Ratna Hany P.	Dr. Agus Marvianto
Jabatan	Ketua Komite PPI	Kadiv Mutu	Direktur Rumah Sakit
Tanda tangan			

CONTROLLED